

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	兒用鼻胃管置放及灌食 Insertion of Nasogastric Tube and Feeding for Child and Infant				
編號	A31000-Q05-W-D04	制定者	IR 黃淑媛	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 04 月 08 日
版本/總頁數	第 3.9 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 15 日

一、目的

護理人員能正確的操作兒用鼻胃管之技術。

二、範圍

兒科各單位。

三、說明

（一）技術目的

1. 供給液態的營養食物。
2. 胃腸減壓。
3. 觀察引流物之性狀，並可依醫囑抽取胃液標本。
4. 藥物投予。
5. 減低噁心、嘔吐感。
6. 腸胃沖洗。

（二）用物準備

1. N-G Tube（嬰兒 5-8Fr、幼兒 8-10Fr、兒童 10-12Fr。）。
2. 5 c.c.或 10 c.c.空針一支（或灌食空針）。
3. Jelly。
4. 聽診器。
5. 清潔手套。
6. 溫開水。
7. 麻醉膠布。

主題名稱	兒用鼻胃管之技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D04	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/6

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
On N-G Tube 之技術	
目的	
準備用物	
插鼻胃管的程序	
1. 需有鼻胃管放置術同意書。	確認鼻胃管放置術同意書是否簽署完整。
2. 洗手並戴上清潔手套。	
3. 核對醫囑及辨識病人（至少二種以上方法）。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
4. 取 N-G Tube 測量插入長度。	(1)鼻尖至耳垂再至劍突。 (2)由口插入胃管：嘴角至耳垂至劍突的距離。（早產兒儘可能採以口插入鼻胃管的方式）。
5. N-G Tube 前端以溫開水或 Jelly 潤濕。	
6. 採仰臥，抬高頭部 20～30 度。	
7. 將 N-G Tube 輕柔的沿鼻中膈插入胃內。	插入鼻胃管時，如遇阻礙無法順利前進，可將管往後抽回一小段，再小心地向前推進。若兒童主訴疼痛或出現咳嗽、呼吸困難發紺等現象時，應立即將鼻胃管抽出，讓其休息一會兒後，再重新潤滑管子，由另一鼻孔插入。
8. 測試 N-G Tube 是否在胃內 (1)反抽可抽出胃液。 (2)置聽診器於胃部位置，早產兒或新生兒以空針打入 1～2c.c.之空氣，確認聽到打入胃的聲音，幼兒放置 8-10Fr. N-G Tube 空針打入 5～10c.c.之空氣；兒童選擇 10-12Fr. N-G Tube，宜打入 10～20 c.c.空氣以確認空氣打入胃內然後再將空氣回抽。	(1)反抽之胃液，藉重力流回胃內。 (2)打入之空氣需再回抽，以避免空氣侵入，致腹脹不適。
9. 以麻醉膠布固定並標明插入日期及到期日。	通常口鼻胃管 7 天更換一次及輪流插不同的鼻孔。
N-G Feeding 之技術	
1. 洗手。	
2. 核對醫囑及辨識病人（至少二種以上方法）。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
3. 採仰臥，抬高頭部 20～30 度。	

主題名稱	兒用鼻胃管之技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D04	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/6

步驟	說明
4. 確定鼻胃管位置。	若持續反抽仍有大量空氣時，應懷疑 N-G 是否已移位。
5. 以空針反抽胃內容物，並觀察消化情形。	N-G 反抽遇阻力時，勿強行再抽吸若反抽超過原本餵食之 1/2 則暫停餵食，藉重力將反抽物引流回胃內。
6. 抬高針筒使液面距胃部距離 6~8 吋 (15~20 公分)，藉重力原理讓溶液流入胃內。	
7. 灌食後倒入溫開水清潔 N-G Tube。	嬰兒 5~8Fr.灌食後倒入 1~2 c.c.溫開水。 幼兒 8-10Fr.灌食後倒入 5~10 c.c.溫開水。 兒童 10-12Fr.灌食後倒入 10~20 c.c.溫開水。
8. 灌食後抬高頭部 20~30 度或建議右側臥以利腸胃引流。	
9. 記錄反抽物之量、性狀及灌入溶液之量。	
注意事項：	
1. N-G Tube 每七天更換，更換時應注意輪流插不同的鼻孔。	為確保兒童不拔除鼻胃管，必要時經醫師同意並向家屬或病童解釋同意約束後予以協助家屬填寫保護約束同意書。
2. 每天給予鼻胃管護理並旋轉 45~90 度。	因為若固定不動，N-G Tube 尾端出口處會對胃壁某固定點造成長期刺激而導致潰瘍。
3. 給予口腔護理每班至少一次。	
4. 行胃腸減壓之目的者要將 N-G Tube 末端之蓋子打開並置入清潔的藥袋中。	
5. 拔除鼻胃管時應先將鼻胃管反抽後再拔出，以避免吸入性肺炎。	

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	兒用鼻胃管之技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D04	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/6

六、參考資料

- (一) 林貴滿等合著(2014)・鼻胃管插入法・內外科護理技術(八版)・台北：華杏。
- (二) 邱雲子、葉淑惠(2012)・應用羅氏適應模式於一位皮爾羅賓氏症案童之護理經驗・秀傳醫學雜誌，11(3.4)，119-127。
- (三) 李淑杏等著(2019)・鼻胃管插入法・產兒科護理技術(四版)・台北：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	兒用鼻胃管之技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D04	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	3.1	1. 用物準備刪除：紙膠。 2. 步驟及要點說明部份修辭。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.12.16	3.2	新增參考資料及更新版本。	103 年 12 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.12.15	3.3	1. 第三項說明內容用辭修飾。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 12 月 15 日護理部技術標準委員會通過。
105.12.20	3.4	修正第三項第(三)目之病人辨識說明。	105 年 12 月 20 日護理部技術標準委員會通過
106.12.18	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.12.16	3.5	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 09 日護理技術組會議通過;108 年 12 月 11 日護理長會議通過;108 年 12 月 16 日督導會議通過公布。
110.01.19	3.6	第三項第三目之 8 新增說明。	109 年 12 月 14 日護理技術組會議通

主題名稱	兒用鼻胃管之技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D04	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
			過;110 年 01 月 13 日護理長會議通過;110 年 01 月 19 日督導會議通過公布。
111.03.08	3.7	第三項第三目之 1 新增說明內容。	110 年 12 月 13 日護理技術組會議通過;111 年 01 月 12 日護理長會議通過;111 年 03 月 08 日督導會議通過公布。
111.12.19	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.01.23	3.8	更新第六項參考資料。	112 年 12 月 19 日護理技術組會議通過;113 年 01 月 10 日護理長會議通過;113 年 01 月 23 日督導會議通過公布。
114.04.08	3.9	修訂主題名稱：兒用鼻胃管置放及灌食。	113 年 12 月 16 日護理技術組會議通過;114 年 03 月 12 日護理長會議通過;114 年 04 月 08 日督導會議通過公布。
114.12.15	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	